



Centre Hospitalier Universitaire de Paris

— Service de Pneumologie

Doc ID: FR-RC-2024-01584 | Date: 14/09/2024

RÉSUMÉ CLINIQUE

SYNTHETIC — RESEARCH USE ONLY

INFORMATIONS DU PATIENT

Patient	Dubois, Jean-Pierre	Date de naissance	18/05/1965 (59 ans)
Adresse	24 Rue de la Paix, 75008 Paris, Île-de-France	N° Sécurité Sociale	1 65 05 75 020 123 45
N° Dossier Patient	CHU-P-2024-334891	Médecin traitant	Dr. Isabelle Moreau, Pneumologue
Date d'admission	10/09/2024 Sortie : 14/09/2024	Mutuelle	MGEN — Contrat n° 75-98-2201-3344

1 — DIAGNOSTICS PRINCIPAUX

Diagnostic principal : Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) stade III — GOLD C (J44.1)
Diagnostics associés : Insuffisance respiratoire chronique (J96.1), Emphysème pulmonaire (J43.9), Tabagisme sévéré (Z87.891), Hypoxémie chronique (R09.02)

2 — ANAMNÈSE ET MOTIF D'HOSPITALISATION

M. Dubois est admis en urgence pour exacerbation aiguë de sa BPCO sévère connue. Il rapporte une aggravation progressive de la dyspnée depuis 5 jours, avec augmentation du volume et de la purulence des expectorations, sensation d'oppression thoracique et impossibilité de réaliser ses activités quotidiennes (dyspnée de repos). Tabagisme actif jusqu'en 2018 : 38 paquets-années. Traitement habituel : Tiotropium 18 µg 1 inhalation/jour, Formotérol 12 µg 2x/jour, Budésonide 400 µg 2x/jour, Salbutamol 100 µg en cas de besoin.

3 — EXAMENS COMPLÉMENTAIRES ET RÉSULTATS

Paramètre	Admission	Sortie	Référence
SpO ₂ (air ambiant)	84 %	91 %	95-100 %
PaO ₂ (gaz du sang)	51 mmHg	63 mmHg	75-100 mmHg
PaCO ₂	52 mmHg	47 mmHg	35-45 mmHg
VEMS / CVF (spirométrie)	42 % / 65 %	—	—
Fréquence respiratoire	26/min	18/min	12-20/min
CRP	87 mg/L	21 mg/L	< 5 mg/L
Globules blancs	13,4 × 10 ⁹ /L	8,7 × 10 ⁹ /L	4-11 × 10 ⁹ /L
Hémoglobine	16,2 g/dL	16,1 g/dL	13-18 g/dL

Radiographie thoracique : Hyperinflation bilatérale, horizontalisation des côtes, aplatissement des coupes diaphragmatiques, pas d'infiltrat pneumonique franc. TDM thoracique : Emphysème centro-lobulaire diffus prédominant aux lobes supérieurs, pas d'embolie pulmonaire. ECG : Tachycardie sinusale, axe droit, aspect S1Q3T3 discret.

4 — TRAITEMENT ET RECOMMANDATIONS À LA SORTIE

Traitement instauré : O₂ nasale 2 L/min en continu, nébulisations salbutamol + ipratropium toutes les 4 h, méthylprednisolone 40 mg/j IV × 5 j, amoxicilline-acide clavulanique 1 g × 3/j PO × 7 j.
Prescription de sortie : Oxygénothérapie de longue durée (OLD) 15 h/j (débit 2 L/min au repos, 3 L/min à l'effort), poursuite triple thérapie inhalée, vaccination grippe + pneumocoque.

Suivi :

Consultation pneumologie dans 4 semaines; bilan sanguin (NFS, gaz du sang) dans 6 semaines; réhabilitation respiratoire programmée.

⚠ *SYNTHETIC DOCUMENT — All patient data, names, identification numbers and clinical details in this document are entirely fictional and have been generated for AI research purposes. Any resemblance to real persons is purely coincidental. Not for clinical use.*